



**FACULDADE FAIPE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

**ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM**

**ESTUDO COMPARATIVO SOBRE AS TÉCNICAS DE RASPAGEM  
SUBGENGIVAL NÃO CIRÚRGICA *VERSUS* RASPAGEM SUBGENGIVAL  
CIRÚRGICA: PRÓS E CONTRAS**

Belo Horizonte  
2025

**ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM**

**ESTUDO COMPARATIVO SOBRE AS TÉCNICAS DE RASPAGEM  
SUBGENGIVAL NÃO CIRÚRGICA *VERSUS* RASPAGEM SUBGENGIVAL  
CIRÚRGICA: PRÓS E CONTRAS**

Monografia apresentada ao Instituto de  
Ensino Superior – FAIPE, para obtenção  
do título de Especialista em Periodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de  
Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e  
Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

Belo Horizonte  
2025

**ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM**

**ESTUDO COMPARATIVO SOBRE AS TÉCNICAS DE RASPAGEM  
SUBGENGIVAL NÃO CIRÚRGICA *VERSUS* RASPAGEM SUBGENGIVAL  
CIRÚRGICA: PRÓS E CONTRAS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

**Banca examinadora**

---

Prof. <sup>a</sup>

---

Membro  
Prof.

---

Membro  
Prof.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

## RESUMO

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que compromete os tecidos de suporte dentário, sendo considerada um dos principais desafios da odontologia contemporânea. Seu tratamento é essencialmente mecânico, centrado na remoção do biofilme e do cálculo dental por meio da raspagem subgengival. Essa técnica pode ser aplicada tanto de forma não cirúrgica quanto cirúrgica, a depender da gravidade do caso clínico. A literatura evidencia que a abordagem não cirúrgica é eficaz principalmente nos estágios iniciais da doença, enquanto a intervenção cirúrgica tende a ser necessária em casos mais avançados, quando a resposta ao tratamento conservador é limitada. O presente estudo teve como objetivo comparar essas duas técnicas, identificando suas indicações, vantagens e limitações. Por meio de revisão integrativa, foi possível constatar que a escolha do método deve ser pautada em critérios clínicos bem definidos, considerando-se a profundidade das bolsas periodontais, a resposta do paciente ao tratamento inicial e fatores sistêmicos associados. A personalização da terapia e a adoção de estratégias baseadas em evidências são determinantes para o sucesso a longo prazo na manutenção da saúde periodontal.

Palavras-chave: Periodontite. Raspagem. Técnica cirúrgica. Técnica não cirúrgica. Sondagem.

## **ABSTRACT**

Periodontitis is a chronic inflammatory disease that affects the supporting dental tissues and is considered one of the main challenges in contemporary dentistry. Its treatment is essentially mechanical, focusing on the removal of biofilm and dental calculus through subgingival scaling. This technique can be applied in both nonsurgical and surgical forms, depending on the clinical severity of each case. The literature shows that nonsurgical therapy is particularly effective in the early stages of the disease, while surgical intervention tends to be necessary in more advanced stages, especially when conservative treatment fails to achieve the desired outcomes. This study aimed to compare these two approaches, identifying their indications, advantages, and limitations. Through an integrative review, it was observed that the choice of treatment should be based on well-defined clinical criteria, considering the depth of periodontal pockets, patient response to initial therapy, and associated systemic conditions. Personalized treatment planning and evidence-based strategies are crucial for long-term success in the maintenance of periodontal health.

Keyword: Periodontitis. Scaling. Surgical technique. Non-surgical technique. Probing.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Elementos principais do periodonto .....                                                                                                                                                                                                       | 12 |
| Figura 2 – Gengivite e periodontite. A (gengivite): o cálculo se acumula nos dentes e as gengivas ficam inflamadas. B (periodontite): A inflamação faz com que a gengiva se separe do dente, formando bolsas. Há também a destruição do osso alveolar.... | 14 |
| Figura 3 - Sondagem.....                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |

## LISTA DE QUADROS

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Quadro 1 - Estágios da Periodontite .....             | 16 |
| Quadro 2 - Graus da Periodontite .....                | 17 |
| Quadro 3 - Vantagens e desvantagens da raspagem ..... | 19 |

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| OMS | Organização Mundial da Saúde    |
| RAR | Raspagem e alisamento radicular |

## SUMÁRIO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                    | 9  |
| 2 DESENVOLVIMENTO .....               | 12 |
| 2.1 PERIODONTITES E SEUS GRAUS .....  | 12 |
| 2.2 TRATAMENTO DE PERIODONTITES ..... | 18 |
| 2.2.1 Raspagem .....                  | 18 |
| 2.2.1.1 Técnica não cirúrgica .....   | 20 |
| 2.2.1.2 Técnica cirúrgica .....       | 22 |
| 3 CONCLUSÃO .....                     | 25 |
| REFERÊNCIAS .....                     | 26 |

## 1 INTRODUÇÃO

As doenças periodontais são um dos maiores desafios da saúde bucal, que afeta milhões de pessoas em diferentes faixas etárias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em nível mundial mais de 1 bilhão de pessoas são acometidas por doenças periodontais graves (WHO, 2022). A nível Brasil, a prevalência de periodontite atinge cerca de 20% da população adulta, especialmente a partir dos 35 anos de idade (Brasil, 2018).

A periodontite, causada pela formação da placa bacteriana na parte superior e embaixo da linha da gengiva, é uma doença inflamatória crônica que desencadeia destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso alveolar. Além de comprometer a saúde bucal, essa condição tem sido associada a diversas patologias sistêmicas, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças respiratórias e até complicações na gestação (Medeiros et al., 2022). Isso porque a periodontite, nada mais é que o resultado do acúmulo de placa bacteriana mineralizada (nas porções sub e supra gengival) que se determina em tártaro (cálculo dental), que por sua vez contém bactérias que causam inflamações nas gengivas e tecidos periodontais, que podem, inclusive migrar pela corrente sanguínea para órgãos vitais, como o pulmão e o coração, afetando a saúde em geral (Pinho, 2025).

Mediante seu caráter degenerativo e irreversível (em casos em que não é tratada adequadamente) reforça-se a importância da intervenção profissional precoce, uma vez que os tecidos periodontais não se regeneram espontaneamente. E assim, diante dessa complexidade, torna-se evidente a necessidade de um tratamento que seja ao mesmo tempo eficaz e adaptado ao estágio da condição (Pinho, 2025).

O tratamento periodontal contemporâneo busca não apenas controlar a infecção, mas preservar a estrutura dentária, melhorar a função mastigatória e promover saúde a longo prazo. Nesse contexto, o tratamento da periodontite envolve uma união de técnicas que em conjunto, visam diminuir o risco de progressão da condição, atuando tanto na eliminação do fator causal quanto na manutenção dos resultados obtidos (Pinho, 2025).

Entre os procedimentos mais utilizados, destaca-se a raspagem, um tratamento mecânico, considerado padrão ouro no tratamento da periodontite, que pode acontecer tanto na porção supragengival quanto na porção subgengival (Pinho, 2025).

Nesse caso, destaca-se que a técnica (raspagem) que visa a remoção de cálculo e biofilme é fundamental para interromper a destruição do tecido de suporte dentário e restaurar a saúde periodontal. Contudo, sua aplicação pode variar de acordo com a gravidade da periodontite, sendo indicada tanto na fase inicial do tratamento quanto como medida complementar em casos mais avançados (Bianchini, 2024).

A raspagem supragengival envolve a remoção do tártaro aderido à parte visível dos dentes. O processo, na maioria dos casos, é feito sem sedação ou anestesia. E a técnica envolve o uso de instrumentos, como o ultrassom, que visam a remoção do tártaro no esmalte dentário e cimento (Pinho, 2025).

A raspagem subgengival, por sua vez, pode ser realizada por meio de duas abordagens principais: a técnica não cirúrgica e a técnica cirúrgica. A escolha entre uma e outra depende de múltiplos fatores, como profundidade da bolsa periodontal, presença de defeitos ósseos e resposta do paciente às intervenções iniciais (Souza; Lima, 2021).

Sobre a raspagem subgengival, parece haver um consenso de que as periodontites leves ou moderadas (graus I e II) são melhores tratadas com a terapia não cirúrgica. Por outro lado, os tipos graves de periodontite (graus III e IV) são tradicionalmente tratados cirurgicamente pela maioria dos clínicos (Bianchini, 2024).

Contudo, apesar dessa condição consensual, ainda assim, o tema suscita discussões sobre efetividade, custo-benefício, recuperação e prognóstico entre os profissionais da área (Bianchini, 2024).

Nesse cenário, justifica-se a realização de um estudo que compare diretamente os prós e contras das técnicas cirúrgica e não cirúrgica de raspagem subgengival. Considerando que a escolha do método interfere diretamente nos resultados clínicos, é essencial compreender suas indicações específicas, limitações e benefícios a curto e longo prazo. Este trabalho pretende contribuir com a prática clínica baseada em evidências, fornecendo subsídios para decisões mais seguras, personalizadas e eficientes no tratamento periodontal.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como problema de pesquisa: Qual das técnicas de raspagem subgengival (cirúrgica ou não cirúrgica) apresenta melhores resultados clínicos e menos efeitos adversos, considerando o grau da periodontite? Como objetivo geral, propõe-se comparar os efeitos e desfechos clínicos da raspagem subgengival cirúrgica e não cirúrgica. Como objetivos específicos, pretende-se: descrever os protocolos de cada técnica; avaliar os benefícios e limitações das abordagens; e analisar suas indicações clínicas conforme os diferentes graus da periodontite.

A presente investigação será conduzida a partir de revisão bibliográfica integrativa, com o intuito de reunir e confrontar os conhecimentos disponíveis na literatura científica. Serão avaliadas pesquisas nacionais e internacionais, diretrizes clínicas e publicações relevantes que abordem a eficácia terapêutica, os impactos pós-operatórios, o tempo de recuperação e o índice de recidiva das técnicas estudadas. Espera-se, com isso, contribuir para a melhoria dos cuidados periodontais e auxiliar os profissionais da odontologia na tomada de decisões baseadas em evidências científicas sólidas.

## 2 DESENVOLVIMENTO

### 2.1 PERIODONTITES E SEUS GRAUS

As doenças periodontais são condições deletérias que afetam os tecidos que envolvem e sustentam os dentes, conhecidos coletivamente como periodonto (Aguilar, 2022). De etiologia multifatorial tendo a má higiene bucal como fator etiológico primário tanto da gengivite quanto da periodontite, é preciso mencionar que a progressão da gengivite para periodontite depende de uma combinação de fatores secundários/moduladores, como: predisposição genética, tabagismo, diabetes mellitus, estresse, alterações hormonais e sistema imunológico deficiente, que afetam a resposta do hospedeiro (Steffens; Marcantonio, 2018; Aguilar, 2022).

Contudo, para compreender o impacto dessas condições, é essencial conhecer a estrutura periodontal, que é composto por quatro elementos principais: gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal, os quais atuam de forma integrada para manter o dente fixo e funcional na cavidade bucal (Figura 1). Assim, enquanto a gengiva oferece a proteção, o ligamento periodontal em conjunto com o cemento radicular e o osso alveolar oferecem suporte (Gontijo, 2021).

Figura 1 - Elementos principais do periodonto



Fonte: Google Imagens (2025)

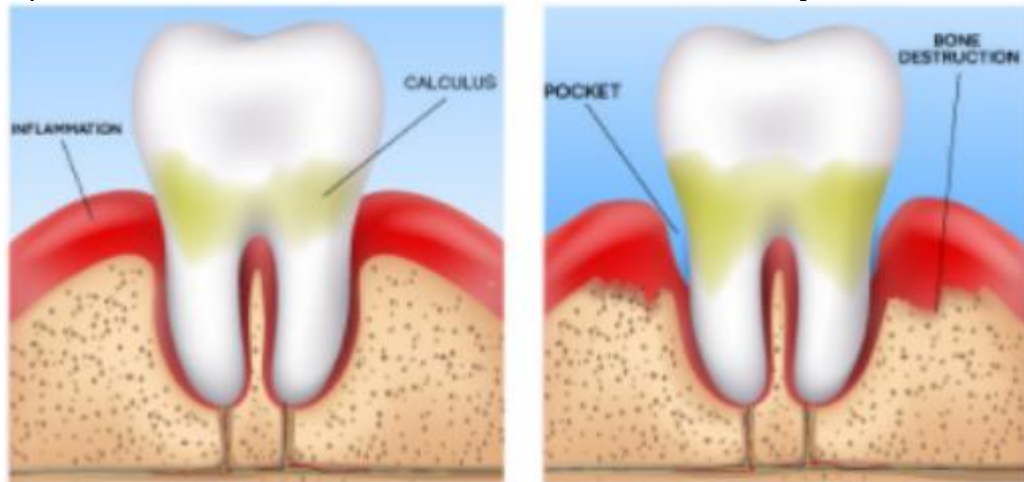
Para que o periodonto mantenha-se em homeostase, a manutenção da saúde deve ser preconizada através da higiene. Isso significa que a saúde periodontal está diretamente relacionada a cuidados básicos, mas fundamentais, como a escovação correta e o uso do fio dental. Em função, pauta-se que a higiene bucal é integralmente mecânica, e nesse quesito, a escova de dentes é responsável por remover a placa bacteriana da superfície visível dos dentes, enquanto o fio dental atua nas áreas interproximais (Pinho, 2025).

Assim, quando esses hábitos não são realizados adequadamente, ou negligenciados, inicia-se o acúmulo de biofilme sobre os dentes. Nesse caso, inicia-se a formação de uma película viscosa composta por bactérias e resíduos alimentares que aderem à superfície dentária (Melani, 2018).

Com o tempo, esse biofilme pode se mineralizar, formando o tártaro ou cálculo dental, como também pode ser chamado. Esse por sua vez, deposita-se tanto na região supragengival quanto subgengival do dente (Pinho, 2025). Expõe-se ainda que o tártaro, serve como um ambiente ideal para bactérias patogênicas, que desencadeiam inflamações nos tecidos periodontais, sendo esse o processo inflamatório determinado como ponto de partida das periodontites (Tolentino, 2018).

O estágio inicial da condição é denominado gengivite, onde seus sinais clínicos são caracterizados pela inflamação da gengiva, sangramento durante a escovação e inchaço gengival. Nesta fase, não há perda de inserção ou de osso de suporte, e, com o tratamento adequado, a condição é reversível. No entanto, se a gengivite não for tratada, pode evoluir para um estágio mais grave: a periodontite (Figura 2) (Pinho, 2025).

Figura 2 – Gengivite e periodontite. A (gengivite): o cálculo se acumula nos dentes e as gengivas ficam inflamadas. B (periodontite): A inflamação faz com que a gengiva se separe do dente, formando bolsas. Há também a destruição do osso alveolar.



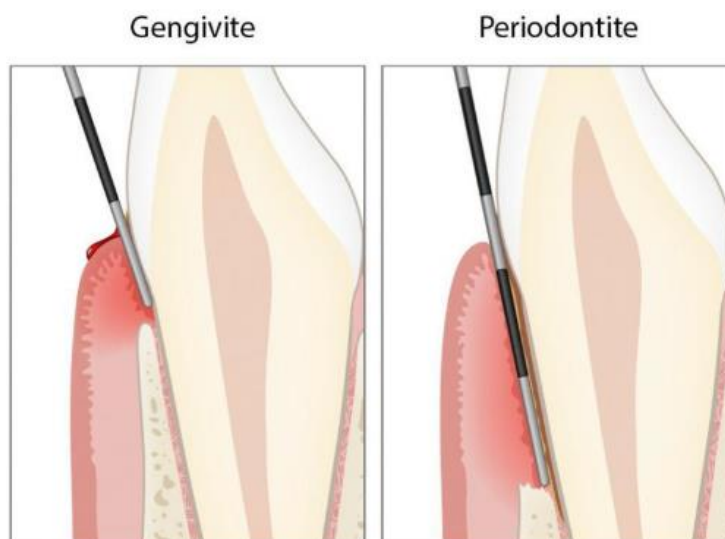
Fonte: Google Imagens (2025)

A periodontite é definida como uma “doença inflamatória crônica multifatorial associada com biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental” (Steffens; Marcantonio, 2018, p. 192). Isso significa que a infecção não se restringe mais à gengiva, mas atinge as estruturas de suporte do dente, provocando perda de inserção, reabsorção óssea e formação de bolsas periodontais, que se caracterizam como espaços entre a gengiva e o dente onde há acúmulo de bactérias e detritos (Serino, 2001).

Clinicamente, a periodontite pode ser identificada quando há perda de inserção clínica (profundidade aumentada à sondagem), observada em pelo menos dois sítios interproximais não adjacentes, ou quando há perda de inserção de 3 mm ou mais nas superfícies vestibulares ou linguais/palatinas de pelo menos dois dentes (Gontijo, 2021). Esses achados devem ser confirmados excluindo-se causas como recessão traumática, cáries cervicais extensas, lesões endoperiodontais, extrações de terceiros molares ou fraturas radiculares verticais (Periodontal-health, 2023).

Nesse prospecto, destaca-se que a sondagem periodontal (Figura 3) é um dos principais instrumentos clínicos para o diagnóstico da periodontite. Ela permite mensurar a profundidade das bolsas periodontais e avaliar o nível de inserção periodontal (Periodontal-health, 2023).

Figura 3 - Sondagem



Fonte: Periodontal-health (2023)

Determina-se que bolsas com profundidade acima de 3 mm já podem indicar comprometimento periodontal, sendo que profundidades maiores que 5 mm geralmente são associadas a perda óssea significativa (Gontijo, 2021).

Mediante diagnóstico, a periodontite é classificada segundo seu estágio e grau, critérios que consideram a gravidade da perda de inserção, extensão da destruição óssea, complexidade do tratamento e risco de progressão da doença (Michaud et al., 2017).

A classificação atual da periodontite, proposta pela Federação Europeia de Periodontologia e pela Academia Americana de Periodontologia, considera dois eixos principais para caracterizar a doença: estágio e grau. Essa abordagem permite avaliar tanto a gravidade atual quanto a velocidade de progressão e os riscos associados, tornando a conduta clínica mais precisa e personalizada (Murakami et al., 2018).

No que tange ao estágio da periodontite, determina-se que ele refere-se à extensão da destruição dos tecidos periodontais (até 30% dos dentes afetados: localizada; mais de 30% dos dentes afetados: generalizada; se a destruição está concentrada nesses grupos dentários: padrão molar/incisivo) no momento do diagnóstico (Tonetti, Greenwell; Kornman, 2018). Ele é determinado com base na perda clínica de inserção (PCI), perda óssea radiográfica e presença de fatores de complexidade clínica. Nesse caso, existem quatro estágios, numerados de I a IV, que

vão desde formas iniciais e leves até formas avançadas e com prejuízo funcional (Lang; Bartold, 2018).

Além da perda de inserção, os estágios também consideram aspectos como a profundidade de sondagem, mobilidade dentária, lesões de furca, padrão de perda óssea (horizontal ou vertical), e quantidade de dentes perdidos por causa da periodontite (Fine; Patil; Loos, 2018).

Nesse prisma, o Quadro 1 evidencia os estágios da periodontite considerando também suas características determinantes e fatores de complexidade.

Quadro 1 - Estágios da Periodontite

| <b>Estágio</b> | <b>Características Determinantes</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fatores de Complexidade</b>                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I              | Perda de inserção interproximal de 1-2 mm ou perda óssea radiográfica < 15% no terço coronal                                                                                                                                                              | Sondagem até 4 mm; sem perda dentária; perda óssea horizontal                                           |
| II             | Perda de inserção interproximal de 3-4 mm ou perda óssea radiográfica de 15-33%                                                                                                                                                                           | Sondagem até 5 mm; sem perda dentária; perda óssea horizontal                                           |
| III            | Perda de inserção $\geq$ 5 mm ou perda óssea se estendendo à metade ou ao terço apical da raiz                                                                                                                                                            | Sondagem $\geq$ 6 mm; perda de até 4 dentes; lesões de furca grau II/III; perda óssea vertical até 3 mm |
| IV             | Igual ao Estágio III, com critérios adicionais (pode ocorrer disfunção mastigatória, trauma oclusal secundário (mobilidade grau 2 ou 3), defeito de rebordo grave, problemas mastigatórios, menos de 20 dentes remanescentes (10 pares de antagonistas).) | Perda de 5 ou mais dentes; mobilidade grau 2 ou 3; problemas mastigatórios; < 20 dentes remanescentes   |

Fonte: Steffens e Marcantonio (2018) – Adaptado.

No que tange ao grau, esse indica a velocidade de progressão da doença e sua influência na saúde sistêmica. Ele também considera a resposta ao tratamento e a

presença de fatores de risco modificadores, como tabagismo e diabetes (Papapanou et al., 2018).

Nesse caso, o paciente inicialmente é classificado como grau B (progressão moderada), podendo ser reclassificado para grau A (lenta) ou C (rápida) de acordo com evidências clínicas e fatores de risco (Araújo; Lindhe, 2018).

De acordo com Steffens e Marcantonio (2018) a avaliação do grau é baseada em:

- Evidências diretas: perda de inserção ao longo do tempo (avaliada por registros clínicos);
- Evidências indiretas: perda óssea estimada em relação à idade do paciente;
- Fatores modificadores: como número de cigarros/dia e controle glicêmico.

Nesse prisma, o Quadro 2 evidencia os graus da periodontite considerando a sua progressão, características clínicas, bem como fatores de risco.

Quadro 2 - Graus da Periodontite

| <b>Grau</b> | <b>Progressão</b> | <b>Características Clínicas</b>                                                           | <b>Fatores de Risco</b>                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A           | Lenta             | Pouca destruição apesar do acúmulo de biofilme; perda óssea < 0,25 mm/ano                 | Sem tabagismo; sem diabetes mellitus   |
| B           | Moderada          | Destruição proporcional ao biofilme; perda óssea entre 0,25-1 mm/ano                      | Fumantes < 10 cigarros/dia; HbA1c < 7% |
| C           | Rápida            | Destruição maior que o esperado; resposta ruim ao tratamento; progressão ≥ 2 mm em 5 anos | Fumantes ≥ 10 cigarros/dia; HbA1c ≥ 7% |

Fonte: Steffens e Marcantonio (2018) – Adaptado.

## 2.2 TRATAMENTO DE PERIODONTITES

O tratamento da periodontite tem como objetivo principal controlar a infecção e interromper a progressão da destruição dos tecidos periodontais. A abordagem terapêutica é predominantemente mecânica, por meio da remoção do biofilme e do cálculo dental nas superfícies radiculares, através da raspagem e do alisamento radicular. Em muitos casos, essa intervenção é suficiente para restabelecer a saúde periodontal. Entretanto, em quadros mais avançados ou com resposta limitada à terapia mecânica, pode ser necessário o uso de medicamentos como coadjuvantes (como antimicrobianos sistêmicos ou locais), com o intuito de reduzir a carga bacteriana, controlar a inflamação e, em alguns casos, evitar a necessidade de cirurgia periodontal. Quando essas medidas não são suficientes, intervenções cirúrgicas podem ser indicadas para acesso às áreas profundas e correção de defeitos anatômicos nos tecidos periodontais (Bianchini, 2024; Pinho, 2025).

### 2.2.1 Raspagem

A raspagem é um procedimento fundamental no tratamento da periodontite e consiste na remoção mecânica do biofilme subgengival e do cálculo dental aderido às superfícies radiculares. Seu principal objetivo é reduzir a carga bacteriana, interromper o processo inflamatório e promover a cicatrização dos tecidos periodontais (Lo et al., 2021).

Além da raspagem, realiza-se também o alisamento radicular, que consiste no polimento da superfície da raiz para torná-la mais lisa e dificultar nova aderência de bactérias. Apesar de atualmente os termos raspagem e curetagem serem utilizados de forma intercambiável (como sinônimos), tecnicamente há distinção. Isso porque a curetagem dental refere-se à remoção do tecido de granulação dentro da bolsa periodontal; e a raspagem e alisamento radicular (RAR) visam a descontaminação da superfície dentária (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

A raspagem é realizada com instrumentos manuais, como curetas periodontais (ex: Gracey e Columbia), ou com instrumentos mecânicos ultrassônicos, como pontas

de ultrassom e sônicos. O polimento por sua vez é feito com jato de bicarbonato de sódio, taças de borracha e pastas profiláticas (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

Determina-se que a duração da raspagem e alisamento radicular é variável, dependendo da profundidade das bolsas periodontais, da quantidade de cálculo presente, do nível de cooperação do paciente e da habilidade do profissional. Em casos simples, o procedimento pode durar 20 a 40 minutos por quadrante, mas em quadros avançados ou generalizados, pode ser necessário realizar o tratamento em sessões múltiplas (Tolentino, 2018).

Por ser um procedimento que atinge regiões profundas e sensíveis, muitos pacientes relatam desconforto ou dor durante a raspagem. Por isso, é comum o uso de anestesia local infiltrativa ou troncular, geralmente com articaína 4% com epinefrina 1:100.000, especialmente em bolsas profundas ou pacientes mais sensíveis (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

Destaca-se que é comumente relatado pelos pacientes que após o procedimento, pode haver sensibilidade transitória à temperatura ou ao toque, o que tende a diminuir nos dias seguintes à ação mediante higiene adequada e, se necessário, com o uso de dessensibilizantes (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

Embora a técnica de raspagem seja padrão-ouro no tratamento de periodontites, é preciso pautar que a técnica ainda possui desvantagens quanto a sua utilização. Nesse caso, o Quadro 3 traz as vantagens e desvantagens da raspagem.

Quadro 3 - Vantagens e desvantagens da raspagem

| <b>Vantagens</b>               | <b>Desvantagens</b>                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Não invasiva                   | Pode causar sensibilidade                      |
| Evita cirurgia em muitos casos | Requer controle rigoroso de placa              |
| Boa resposta em graus I e II   | Pode ter recidiva se não houver manutenção     |
| Custo acessível                | Resultados limitados em bolsas muito profundas |

Fonte: Morais et al. (2013)

Além disso, é preciso levar em consideração que raspagem e alisamento radicular são geralmente considerados como seguros, todavia devem ser avaliadas com cautela em pacientes com doenças sistêmicas descompensadas (ex:

cardiopatias, diabetes sem controle); indivíduos com alto risco de endocardite infecciosa (devem receber antibiótico na profilaxia) e pacientes com distúrbios hemorrágicos (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

Nesse caso, cabe dizer que não há contraindicação absoluta, mas sim cuidados individualizados, conforme o estado clínico do paciente (Pinho, 2025). Logo, a raspagem não pertence a nenhum “grupo terapêutico permanente”, pois é um procedimento mecânico pontual. No entanto, seus efeitos não são permanentes, assim, eles só são mantidos se houver controle contínuo da placa bacteriana e visitas periódicas ao cirurgião-dentista para a manutenção (Melani, 2018).

Ademais, faz-se importante ressaltar que a raspagem pode ser realizada por meio de duas abordagens terapêuticas distintas: a técnica não cirúrgica, indicada principalmente nos estágios iniciais da periodontite, e a técnica cirúrgica, geralmente reservada para casos mais avançados ou que não respondem adequadamente ao tratamento conservador. A escolha entre uma e outra depende de fatores, como profundidade da bolsa periodontal, presença de defeitos ósseos, acesso à área afetada e resposta clínica prévia (Morais et al., 2013).

#### 2.2.1.1 Técnica não cirúrgica

O tratamento periodontal não cirúrgico (TPNC) é a primeira linha terapêutica indicada para controlar a infecção associada à periodontite, especialmente nos estágios iniciais. Seu principal objetivo é promover a descontaminação das superfícies radiculares por meio de desbridamento mecânico, que envolve procedimentos como RAR, uso de instrumentação ultrassônica, e, em alguns casos, aplicação de tecnologias auxiliares, como o laser (Faria, 2020).

Dentre os instrumentos manuais, as curetas Gracey se destacam pela sua capacidade de promover uma superfície radicular mais lisa e de remover de forma eficaz o cálculo aderido. Entretanto, seu uso exige habilidade técnica apurada, além da necessidade de afiamento frequente, o que pode limitar sua eficácia em mãos menos experientes. Uma desvantagem adicional do uso intensivo de curetas é a possibilidade de provocar hipersensibilidade dentinária, associada à exposição da

dentina e remoção excessiva do cimento radicular, especialmente em bolsas mais profundas (Claffey; Polyzois; Ziaka, 2004).

O uso de instrumentos ultrassônicos tem sido amplamente adotado como forma de otimizar o tempo clínico e melhorar o acesso a áreas de difícil instrumentação, mantendo eficácia semelhante à técnica manual. Já entre as abordagens tecnológicas, o laser Er: YAG tem se mostrado promissor no contexto do tratamento não cirúrgico. Estudos indicam que o Er: YAG é capaz de promover a descontaminação da bolsa periodontal de forma eficiente e minimamente invasiva, com menor desconforto ao paciente e preservação do cimento radicular. Todavia, sua aplicação requer formação especializada e maior investimento técnico, o que limita sua utilização ampla na prática clínica (Vinhas et al., 2020).

De acordo com a literatura, a terapia não cirúrgica é especialmente eficaz nos casos classificados como grau I e II de periodontite. Essa conduta é reforçada pelas diretrizes da *American Academy of Periodontology*, que preconiza o tratamento conservador como abordagem inicial, com reavaliação subsequente da resposta tecidual antes de se considerar a cirurgia (AAP, 2018).

Um ensaio clínico com 30 pacientes (idades entre 33 e 75 anos) portadores de periodontite moderada demonstrou que o tratamento não cirúrgico (raspagem e alisamento radicular, complementados por bochecho com clorexidina) promoveu uma redução significativa no acúmulo de placa e inflamação gengival, além de diminuição estatisticamente relevante nas bolsas com profundidade menor que 5 mm, e ganho de inserção clínica em sítios com profundidade inicial maior que 5 mm (Mlachkova; Popova, 2014). Isso evidencia que, com boa adesão do paciente, a terapia conservadora é eficaz na contenção da doença em periodontites moderadas, apoiando o uso da técnica não cirúrgica nos graus I e II (Debarghya et al., 2021).

Além disso, revisões sistemáticas confirmam que o desbridamento subgengival seja ele manual ou ultrassônico, proporciona reduções médias de sondagem de cerca de 1,5 mm em bolsas de 4–6 mm, o que reforça a eficácia da abordagem inicial antes de proceder à cirurgia (Melani, 2018).

Assim, o tratamento periodontal não cirúrgico representa uma estratégia segura, eficaz e com boa aceitação, especialmente nos estágios iniciais da doença,

proporcionando controle da inflamação, redução de bolsas periodontais e melhora na adesão do paciente ao autocuidado (Ferreira; Ribeiro; Vilhena, 2024).

#### 2.2.1.2 Técnica cirúrgica

Apesar da eficácia demonstrada em diversos estudos, é importante destacar que, em situações de bolsas periodontais persistentes ou refratárias ao tratamento conservador, a intervenção cirúrgica pode ser necessária.

A raspagem subgengival cirúrgica é indicada quando a abordagem não cirúrgica não proporciona os resultados esperados, especialmente em casos em que as bolsas periodontais permanecem com profundidade semelhante à aferida antes do tratamento inicial. Além da persistência da profundidade, o profissional deve considerar a presença de sinais clínicos de inflamação ativa, como exsudato purulento e sangramento durante a sondagem (Lindhe; Karring; Lang, 2005).

A principal finalidade da intervenção cirúrgica periodontal é reduzir a profundidade das bolsas periodontais, permitindo acesso visual e físico direto à superfície radicular. Essa abordagem facilita a remoção do cálculo subgengival e possibilita a correção de defeitos ósseos e de tecidos moles, contribuindo para a manutenção da saúde periodontal a longo prazo (Lindhe; Karring; Lang, 2005; Carranza et al., 2007).

Existem diferentes técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas, conforme o tipo e a gravidade da lesão periodontal. Uma das mais comuns é a cirurgia a retalho, que permite o levantamento de um retalho gengival para acesso direto à região afetada. Esse procedimento é conhecido como raspagem “a céu aberto” e possibilita não apenas a descontaminação eficaz da superfície dentária, mas também o aplainamento de áreas ósseas irregulares que poderiam favorecer o acúmulo de placa bacteriana (Lindhe; Karring; Lang, 2005; Cohen, 2008).

Em casos de perda óssea significativa, podem ser empregados enxertos ósseos, que visam restabelecer a arquitetura óssea do periodonto. Esses enxertos podem ser autógenos (do próprio paciente) ou heterógenos, e servem como matriz para a formação de novo osso na região danificada. Além disso, pode ser necessária

a utilização de enxertos de tecido mole, especialmente em áreas com recessão gengival acentuada, para reconstruir a estética e a funcionalidade da gengiva perdida (Lindhe; Karring; Lang, 2005).

Outra técnica importante é a regeneração tecidual guiada, que consiste na instalação de uma membrana entre o osso e o tecido gengival, com o objetivo de impedir que o epitélio – que se prolifera mais rapidamente – ocupe a área de regeneração, permitindo assim que o tecido conjuntivo e o osso se desenvolvam adequadamente (Cohen, 2008; Melani et al., 2018). Já a cirurgia óssea envolve a exposição da área óssea por meio de um retalho de espessura total, permitindo a regularização do osso alveolar, contribuindo para a melhoria da saúde oral e redução do acúmulo de biofilme (Lindhe; Karring; Lang, 2005; Melani et al., 2018).

Uma revisão sistemática realizada por pesquisadores da área evidenciou que, em casos de bolsas rasas (1 a 3 mm), não há diferença significativa entre o tratamento cirúrgico e não cirúrgico quanto à redução da profundidade. No entanto, para bolsas moderadas (4 a 6 mm) e profundas (> 6 mm), o tratamento cirúrgico demonstrou ser mais eficaz, com melhor resposta clínica e maior controle da progressão da doença periodontal (Health Partners, 2011).

Essa evidência clínica sustenta a prática prevalente entre os profissionais de optar pela cirurgia em casos graves de periodontite, especialmente nos graus III e IV, conforme observado em estudos como uma coorte de 386 pacientes com periodontite estágios III e IV acompanhados por 30 anos: apesar do tratamento convencional, a maioria precisou de cirurgia para controle efetivo e preservação dentária ao longo do tempo (Sanz et al., 2021).

Assim, a escolha pela intervenção cirúrgica deve ser tomada com base na reavaliação clínica, realizada geralmente entre 4 e 6 semanas após a última sessão de raspagem subgengival. Nessa fase, são comparadas as medidas de profundidade de sondagem com os dados da consulta inicial, além de outros parâmetros como mobilidade dentária, sangramento, presença de supuração e qualidade da higiene bucal. Esses fatores em conjunto indicam se houve resposta positiva ao tratamento não cirúrgico ou se há necessidade de avançar para uma abordagem cirúrgica (Health Partners, 2011).

Deste modo, é fundamental ressaltar que o sucesso da cirurgia periodontal depende também do acompanhamento pós-operatório e da terapia de manutenção. Essa etapa visa manter os resultados obtidos e evitar recidivas, promovendo a preservação do periodonto a longo prazo e facilitando o controle mecânico da placa bacteriana pelo profissional e pelo próprio paciente (Melani et al., 2018).

### 3 CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou compreender as diferentes abordagens terapêuticas aplicadas no tratamento da periodontite, enfatizando suas indicações, vantagens, limitações e implicações clínicas. Verificou-se que a raspagem subgengival, tanto na forma não cirúrgica quanto na cirúrgica, constitui a base do tratamento periodontal, sendo essencial para o controle da infecção e preservação das estruturas de suporte dentário.

A análise comparativa entre as técnicas demonstrou que, embora a terapia não cirúrgica seja eficaz e preferencial nos estágios iniciais da doença, sua efetividade diminui conforme a gravidade aumenta, tornando a intervenção cirúrgica uma alternativa necessária em casos mais avançados. Observou-se também que a escolha do tratamento deve ser individualizada, considerando a extensão da doença, a resposta tecidual à terapia inicial e as condições sistêmicas do paciente.

Portanto, reforça-se a importância de um diagnóstico preciso e de uma abordagem baseada em evidências, que permita a seleção do tratamento mais adequado para cada situação clínica. A adoção de estratégias preventivas, o acompanhamento contínuo e o envolvimento do paciente no controle da higiene bucal são fatores decisivos para o sucesso terapêutico e a manutenção da saúde periodontal a longo prazo.

## REFERÊNCIAS

AGUIAR, FJN. **Doença periodontal, gengivite, periodontite, perda dentária e adenocarcinoma gástrico: revisão sistemática e metanálise**. 2022. 62p. Dissertação (mestrado em Ciências), Fundação Antônio Prudente, São Paulo, 2022.

AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY – AAP. **The official proceedings from the 2017 Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions**. 2018. Disponível em: <https://www.perio.org/research-science/2017-classification-of-periodontal-and-peri-implant-diseases-and-conditions/>. Acesso em 30 jun. 2025.

Araujo MG, Lindhe J. Peri-implant health. **J Clin Periodontol.**, v. 45, p. 230-236, 2018.

ARAUJO, MG; LINDHE, J. Peri-implant health. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 20, p. 230-236, 2018.

BIANCHINI, M. **Tratamento periodontal não cirúrgico x cirúrgico**. 2024. Disponível em: <https://revistaimplantnews.com.br/tratamento-periodontal-nao-cirurgico-x-cirurgico/>. Acesso em 30 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa\\_nacional\\_saude\\_bucal.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf). Acesso em 13 mai. 2025.

CARRANZA, FA; et al. **Periodontia Clínica**. São Paulo: Guanabara Koogan; 2007.

CLAFFEY, N; POLYZOIS, I; ZIAKA, P. An overview of nonsurgical and surgical therapy, **Periodontology 2000**, v. 36, p. 35-44, 2004.

COHEN, ES. Atlas de cirurgia periodontal reconstrutiva e cosmética. São Paulo: Santos Livraria e Editora; 2008.

DEBARGHYA, P; et al. Non surgical periodontal therapy: An evidence-based perspective. **The Journal of Dental Panacea**, v. 3, n. 2, p. 48-51, 2021.

FARIA, FMLFM. **Tratamento periodontal de acesso cirúrgico Vs tratamento periodontal não-cirúrgico**. Tese (doutorado), Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, Porto, 2015.

FERREIRA, DC; RIBEIRO, SEL; VILHENA, AT. Terapias não cirúrgicas no tratamento da periodontite: uma revisão atualizada. **Ciências da Saúde**, v. 28, n. 130, p. 1-8, 2024.

FINE, DH; PATIL, AG; LOOS, BG. Classification and diagnosis of aggressive periodontitis. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 20, p. 95-111, 2018.

GONTIJO, GR. **Propedêutica Clínica: Periodontia**. Faculdade Anhanguera. 2021. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/64502/1/Propedeutica%20Clinica%2001.pdf>. Acesso em 30 jun. 2025.

HEALTH PARTNERS DENTAL. Health Partners Dental Group and Clinics guidelines for the diagnosis & treatment of periodontal diseases. 2011. Disponível em: <http://www.guideline.gov/>. Acesso em 30 jun. 2025.

LANG, NP; BARTOLD, PM. Periodontal health. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 21, p. 9-16, 2018.

LINDHE, J; KARRING, T; LANG, NP. **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**. São Paulo: Guanabara-Koogan; 2005.

LO, CH; et al. Periodontal disease, tooth loss, and risk of oesophageal and gastric adenocarcinoma: a prospective study. **Gut.**, v. 70, n. 3, p. 620-621, 2021.

MEDEIROS, JC; et al. **Relação entre doença periodontal e doenças sistêmicas: uma revisão integrativa**. Revista da Faculdade de Odontologia, v. 29, n. 1, p. 35–42, 2022.

MELANI, RFH; et al. Quando se deve realizar tratamento cirúrgico periodontal associado ao tratamento convencional?. **Conexão UNNA**, p. 5-7, 2018.

MICHAUD, DS; FU, Z; SHI, J; CHUNG, M. Periodontal Disease, Tooth Loss, and Cancer Risk. **Epidemiol Rev.**, v. 39, n. 1, p. 49-58, 2017.

MLACHKOVA; AM; POPOVA, CL. Efficiency of nonsurgical periodontal therapy in moderate chronic periodontitis. **Folia Med (Plovdiv)**, n. 56, n. 2, p. 109-115, 2014.

MORAIS, T; et al., **tratamento cirúrgico versus tratamento não cirúrgico da periodontite**. IV Jornada Acadêmica de Odontologia 2013. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/acaodonto/article/view/3884/1987>. Acesso em 30 jun. 2025.

MURAKAMI, S; MEALEY, BL; MARIOTTI, A; CHAPPLE, ILC. Dental plaque-induced gingival conditions. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 20, p. 17-27, 2018.

PAPAPANOU, PN; et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 20, p. 162-170, 2018.

PERIODONTAL-HEALTH. **Diagnóstico periodontal**. 2023. Disponível em: <https://www.periodontal-health.com/br/diagnostico/>. Acesso em 30 jun. 2025.

PINHO, I. **Raspagem periodontal: o que é e quais as vantagens desse procedimento?**. 2025. Disponível em: <https://ianarapinho.odo.br/raspagem-periodontal/>. Acesso em 30 jun. 2025.

SANZ, M; et al. **Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP S3 level clinical practice guideline**. J Clin Periodontol., V. 48, N. 1, P. 161-163, 2021.

SERINO, G. et al. Initial outcome and long-term effect of surgical and non- surgical treatment of advanced periodontal disease. **J Clin Periodontol**, v. 28, p. 910-916, 2001.

SOUZA, RT; LIMA, DF. **Tratamentos periodontais cirúrgicos e não cirúrgicos: quando utilizar cada técnica?** Revista Brasileira de Odontologia Clínica e Integrada, v. 25, n. 1, p. 1–10, 2021.

STEFFENS, JP; MARCANTONIO, RAC. Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares 2018: guia Prático e Pontos-Chave. **Rev Odontol UNESP**, v. 47, n. 4, p. 189-197, 2018.

TOLENTINO, PHMP; et al. A importância da participação do paciente para a manutenção da saúde periodontal–revisão de literatura. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, v. 5, n. 3, 2018.

TONETTI, MS; GREENWELL, H; KORNMAN, KS. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. **J Clin Periodontol.**, v. 45, n. 20, p. 149-161, 2018.

VINHAS, ASAF; et al. **A influência do laser Er: YAG no tratamento não cirúrgico da doença periodontal**. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030**. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484>. Acesso em 13 mai. 2025.